ORIGEM DO DOCUMENTO:			
Gerência do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos – FCECON			
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Protocolo Institucional de Manejo da Dor Oncológica Aguda e Crônica na Unidade de Urgência.			PRT.STDCP .001
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
05/12/2025	05/12/2025	01	05/12/2027

1. OBJETIVOS

1.1. Garantir o alívio rápido, seguro e eficaz da dor oncológica aguda e crônica em pacientes atendidos no Serviço de Urgência e Emergência da FCECON, conforme princípios éticos, legais e científicos.

1.2. Padronizar condutas clínicas para avaliação, classificação e tratamento da dor oncológica aguda e crônica, promovendo uniformidade entre as equipes multiprofissionais.

1.3. Identificar precocemente sinais de dor intensa, refratária ou descontrolada, permitindo intervenção imediata para prevenção de sofrimento, complicações e desconfortos associados.

1.4. Controlar a dor e melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes oncológicos independente do estágio do câncer.

1.5. Diminuir o risco de iatrogenias.

2. ABRANGÊNCIA

Pacientes oncológicos adultos, já com prontuários na FCECON, e que apresentam síndromes dolorosas no curso da doença que são admitidos para atendimento na urgência.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Embora a dor, como um sintoma isolado não seja imediatamente fatal, a dor crônica continua sendo um dos sintomas mais frequentes e incapacitantes do câncer principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde o subtratamento é uma realidade. Apesar do papel protetor da dor aguda, que invariavelmente evolui para uma dor crônica no paciente oncológico, ambas estão associadas a pior qualidade de vida e sofrimento nesta população.

Em uma revisão sistemática, incluindo estudos de 2014 a 2021, a prevalência geral de dor em pacientes com câncer foi de 44%. Dor moderada a grave foi experimentada por 31% dos pacientes, já no câncer metastático e terminal avançado a dor foi vivenciada em 55% dos pacientes.

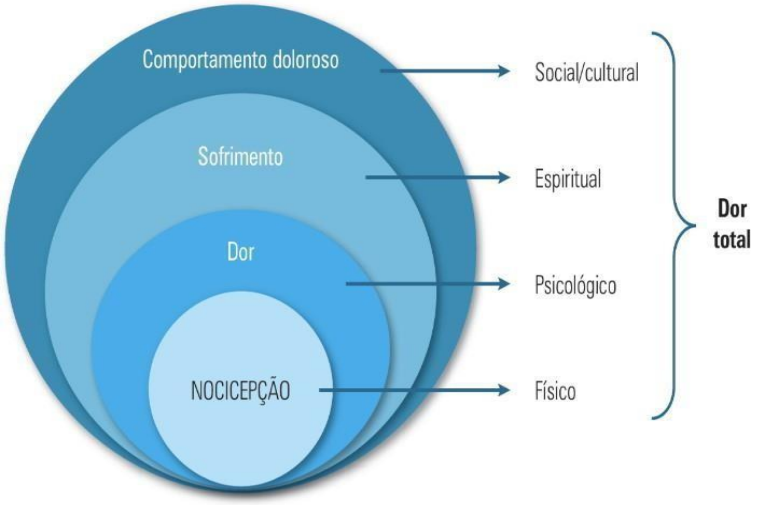
O controle da dor e o alívio do sofrimento são responsabilidade e compromisso do profissional da área de saúde. A falta de consenso na compreensão dos aspectos críticos que compreendem a experiência da dor nos pacientes com câncer avançado ou em fase final de vida, contribui significativamente para a persistência do mau manejo da dor no câncer.

Em 2020 a *International Association for the Study of Pain*, revisou o conceito de dor histórica (1979). A dor foi então definida, como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante a associada a dano tecidual real ou potencial do tecido”. Nas últimas décadas, tem se confirmado a importância do conceito de “dor total” introduzido por Cicely Saunders na década de sessenta e os efeitos multidimensionais que têm sobre a vida do doente e de sua família (Fig 1). Ela é reconhecida como uma sensação única, multifatorial e subjetiva, não havendo analgesia ideal se o manejo da dor não for estrategicamente analisado e planejado individualmente. Por ser multidimensional é importante que o seu manejo seja feito de forma multiprofissional, contemplando as diferentes dimensões.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Figura 1: Relação dos componentes da dor com as dimensões da dor total



Fonte: Internet, 2025.

A tendência dos profissionais de saúde em se concentrar somente na dor física que pode ser medicalizada, negligenciando os outros aspectos que contribuem ou intensificam a dor, também é um grande obstáculo para o manejo adequado da dor.

Cada tipo de dor deve ter o seu mecanismo identificado, como base para um melhor manejo. Os mecanismos de dor não são exclusivos e a coexistência de mais de um é provavelmente a regra e não a exceção. A DOR ONCOLÓGICA É CONSIDERADA MISTA, pois temos a **dor nociceptiva/inflamatória** resultante do crescimento do tumor e das metástases, e a **dor neuropática** resultante da compressão do tumor em estruturas neurais ou por citotoxicidade dos tratamentos antitumorais.

3.1 Avaliação da dor no câncer (highligts)

- A dor oncológica é única, subjetiva e multifatorial, sendo considerada a dor mais incapacitante;
- 70% são decorrentes da invasão tumoral e das metástases: invasão de estruturas ósseas ou de elementos vasculares ou nervosos; obstrução intestinal ou infiltração de vísceras ocas;
- 20% são decorrentes de procedimentos diagnósticos e terapêuticos: incluem intervenções cirúrgicas (dor pós-toracotomia, pós-mastectomia, pós amputação),

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

os efeitos citotóxicos da quimioterapia (mucosite gastrointestinal e orofaríngea, mialgias e artralgias, neuropatias) ou da radioterapia (enterite, cistite, osteonecrose);

- Menos de 10% representam as síndromes induzidas pela neoplasia: por exemplo, síndromes neurológicas paraneoplásicas (neuropatia sensitiva paraneoplásica);
- Uma nova população de pacientes curados, conhecidos como “sobreviventes do câncer” atualmente correspondem 27,6%, que vivenciaram uma dor aguda inadequadamente tratada e evoluíram com dor crônica moderada a grave;
- O paciente pode ainda apresentar síndromes dolorosas não relacionadas com o câncer: artrose, neuropatia pós-herpética, neuropatia diabética, doenças autoimunes inflamatórias, frequentemente associadas a polifarmácia;
- A avaliação deve ser um processo contínuo e dinâmico que inclui o impacto da dor na gênese do sofrimento global (funcional, social, financeiro, cultural e espiritual) do paciente e sua família durante o adoecimento, fatores sabidamente amplificadores da dor (Figura 2).

Figura 2: Ciclo da dor



Fonte: Internet, 2025.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

3.2 Síndromes dolorosas mais frequentes no paciente oncológico

A dor oncológica é a mais prevalente e estudada em cuidados paliativos. As síndromes dolorosas mais frequentes nos pacientes com câncer em unidades de urgência e emergência, são descritas a seguir (Quadro 1).

Tabela 1: Síndromes dolorosas em oncologia

Síndromes	Etiologias	Clínica	Tratamento
Compresão medular	Doença metastática para ossos da coluna. **Câncer mais comum:** Mama, pulmão, próstata, mieloma e linfomas	Dor mais comum em nível torácico (70%), lombar (20%) e cervical (10%). Piora quando se deita. Diagnóstico: RNM / TC	Emergência cirúrgica. Opioides e corticoides são base para a dor.
Dor óssea	**Cânceres mais comuns:** pulmão, mama, próstata e melanoma	Dor súbita (invasão do periósteo e sensibilização dos nervos nos tecidos). Pode levar à fratura patológica Diagnóstico: RX / TC	Opioides, corticoides, Radioterapia, imobilizações, bisfosfonatos.
Dor abdominal	Neoplasia de pâncreas, gástrico, hepático e retroperitoneais; linfomas; isquemia intestinal, retenção urinária, ascite e carcinomatose, víscera rota, constipação.	Infecções intra-abdominais, obstrução intestinal, hemorragias Diagnósticos: Exame físico e imagem.	A depender da etiologia. Para a dor: opioides, analgésicos não opioides e adjuvantes.
Dor fantasma	Dor no membro amputado, dor no coto (palpação e percussão do coto), angina pectoris no braço esquerdo amputado	Pode desenvolver tolerância a medicação	Não farmacológicos e adjuvantes (anticonvulsivantes em especial).
Dor pós mastectomia	Neoplasia de mama. Na emergência atentar para recidiva	Dano do nervo intercostobraquial	Opioides e adjuvantes (em especial gabapentinóides e antidepressivos).

Fonte: Autoria própria, 2025.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO

4.1 Critérios de inclusão

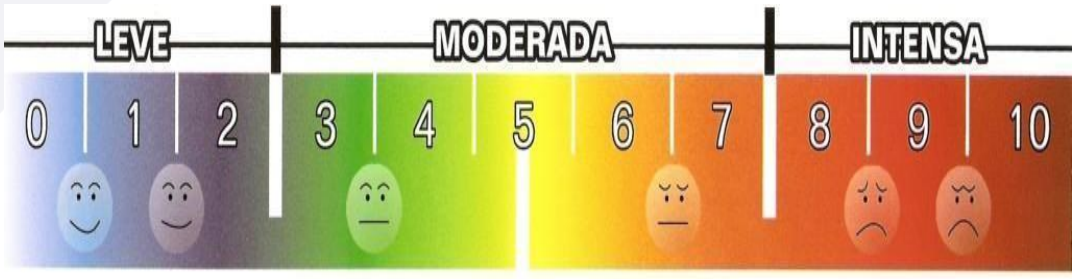
- Pacientes adultos com dor oncológica admitidos na urgência da Instituição.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Avaliação da dor

- Antes de pensar no tratamento, é importante **diagnosticar a dor,** procurando caracterizar os aspectos básicos da dor (localização, intensidade, qualidade da dor e frequência), o estadiamento clínico do câncer, os antecedentes e vigência de tratamento antitumoral e/ou paliativo concomitante, às comorbidades associadas a polifarmácia e identificação de comportamento anômalo relacionado a terapia opioide por meio de instrumentos de rastreio disponíveis: Opioid Risk Tool (ORT) (Anexo 1);
- A avaliação deve ser feita com escalas validadas e apropriado para as condições do paciente. Existem escalas verbais e não verbais bem como escalas de acordo com o grupo populacional a serem avaliados: adultos e/ou crianças;

Figura 3: Representação da escala numérica, a qualitativa, a de cores e a escala de rostos para crianças de 3 a 7 anos



Fonte: Internet, 2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**
Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Realize o histórico da dor. Use a técnica mnemônico **PQRST;**

Tabela 2: Mnemônico PQRST

P	**Provocadores Preciptadores**	**Andar, sentar, repousar, frio movimentar, alimentar, repousar**
Q	**Qualidade da dor**	**Nociceptiva/inflamatória, neuropática, nociplastica, mista**
R	**Região Radiação**	**Dor lombar axial ou radicular**
S	**Severidade dos sintomas associados**	**Fadiga, cefaléia, dor miofascial**
T	**Tempo Tratamento**	**Aguda ou crônica Terapia opióide e adjuvantes**

Fonte: Autoria própria, 2025.

- Estabeleça o diagnóstico da dor e desenvolva um plano individualizado, com base em metas acordadas com o paciente.

5.2 Manejo estratégico da dor

Historicamente, Twycross já tinha proposto uma estratégia de base científica para o manejo adequado da dor total, que é referendada até os dias atuais e que se resume na sigla “EMMA”:

- **E**volução da doença/dor (prognosticando na doença avançada);
- **E**xplicação das causas de dor (tumor, metástases, exames diagnósticos, tratamento antitumoral);
- **M**anejo terapêutico (farmacológicas e não farmacológicas);
- **M**onitorização (da adesão a terapia analgésica multimodal; efeitos adversos);
- **A**tenção aos detalhes (vias de administração inapropriadas e alternativas, disfunção cognitiva dificultando o entendimento da terapia e outros).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

5.3 Manejo farmacológico

O manejo da dor segue o princípio da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde (figura 4). De forma geral, há 3 categorias de analgésicos: os analgésicos não opióides (dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios hormonais e não hormonais), os opióides e os adjuvantes (antidepressivos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, antagonistas NMDA e neurolépticos). Esse protocolo clínico orienta a prescrição de doses fixas, previamente tituladas e doses resgates sistematicamente.

Figura 4: Escala analgésica da Organização Mundial de Saúde (OMS)



Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A Dose Resgate (DR) equivale a 1/6 da dose total nas 24 h. Na terapia com opioide fracos (tramadol e codeína), o resgate costuma ser feito com o mesmo opioide. Em caso de opióides fortes (morfina, metadona, oxicodona, buprenorfina), a DR é feita com morfina de liberação rápida. DR ≥ 4 vezes ao dia são indicativos para aumentar a dose do opioide de horário.

Tabela 3: Recomendações para titulação inicial do tratamento farmacológico da dor oncológica considerando a intensidade da dor

DOR LEVE (EVA 1-3)	DOR MODERADA (EVA 4-7)	DOR INTENSA (EVA 8-10)
-Paracetamol VO 500-750mg 6/6h Dose máxima: 4g/dia -Dipirona VO/EV 500 a 2000mg de 6/6h -Naproxeno VO 250 a 500 mg VO 2x/dia -Ibuprofeno VO 200 a 800 mg VO a cada 6-8h	-Codeina VO 15 – 30mg de 4/4h Dose máxima 360mg/dia - Tramadol VO 50mg de 6/6h Dose máxima: 360mg/dia - Morfina VO Dose inicial 5mg 4/4h -Oxicodona VO 10mg a cada 12h	- Morfina Dose inicial 5 mg 4/4h -Metadona -Buprenorfina transdérmica Titulação inicial por especialistas
DROGAS ADJUVANTES (avaliar a necessidade de prescrição)	DROGAS DJUVANTES (avaliar a necessidade de prescrição)	DROGAS ADJUVANTES (avaliar a necessidade de prescrição)

Fonte: Autoria própria, 2025.

A terapia analgésica multimodal é baseada em interações farmacodinâmicas entre analgésicos opióides e droga adjuvantes que atuam de forma sinérgica e complementar, potencializando o efeito analgésico com diminuição dos efeitos adversos, proporcionando um controle eficaz da dor crônica oncológica.

Adicionalmente as drogas adjuvantes também são usadas para tratar tipos específicos de dor e controlar sintomas que exacerbam a dor. Seguem abaixo alguns deles com recomendações de dose inicial:

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

a) Antidepressivos tricíclicos

- amitriptilina 25 mg/dia.

b) Anticonvulsivantes carbamazepina 200-400/dia

- gabapentina 400 mg/dia;
- pregabalina 75 mg/dia.

c) Neurolépticos

- haloperidol 5mg (IM/SC) Periciazina;
- 1% ou 4% (gotas orais).

d) Ansiolíticos

- diazepam 5-10 mg /dia.

e) Antieméticos

- ondansetrona 8 mg 8/8 horas.

f) Corticosteroides

- Dexametasona 4-10 mg /dia.

5.4 Recomendações para o manejo na unidade de urgência

a) Vias preferenciais são EV e SC na analgesia multimodal;

b) Analgésicos não opióides, como dipirona e paracetamol EV apresentam efeito poupador de opioide e devem ser prescritos;

c) Opióides são a base do tratamento da dor oncológica moderada a intensa. A monitorização dos efeitos adversos e a reavaliação é mandatória pois doses adicionais (DR) são necessárias na fase de titulação;

d) Morfina é o opioide de escolha. Sua dose inicial deve ser titulada a partir de 2mg EV/SC 4/4h em pacientes virgens de opioide, com reavaliação a cada 15 min da administração EV e 30 min da administração SC;

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

e) Para os pacientes em uso de opioide, a dose inicial administrada é a dose total diária VO convertida para EV (3:1), acrescida de 10 %. A tabela de equivalência de opioides deve ser usada na mudança de vias e no rodízio dos opioides (Tabela 1);

f) Atenção especial deve ser dada a idosos frágeis, renais crônicos e hepatopatias com início de doses menores. De forma prática, a dose de 1 mg de morfina para as virgens de opioides e 5% da dose diária do opioide aos usuários crônicos deve ser considerada;

g) A metadona e a buprenorfina por terem excreção essencialmente fecal são as melhores opções para renais crônicos em comparação com a morfina. A própria morfina e os opioides transdérmicos, como a buprenorfina, são priorizados à metadona nos hepatopatas.

h) No manejo da terapia opióide, há de atentar-se para prevenção de náuseas, vômitos e constipação (Ver ponto 6.3.3).

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Tabela 4: Tabela de conversão de opioide tendo como base a morfina VO.

Medicamento	Tempo de ação	Doses									
Codeína oral	4h	30 mg	45mg	60mg							
Tramadol parenteral	6h	50 mg	75mg	100mg							
Tramadol oral	6h	25 mg	37,5mg	50mg	75mg	100mg					
Morfina oral ação rápida	4h			5mg	10mg	15mg	20mg	30mg	40mg	60mg	Acima 120 mg
Morfina oral de longa duração	12h				30mg		60mg	90mg	120mg	180mg	360mg
Morfina parenteral	4h			2mg	3mg	5mg	7mg	10mg	15mg	20mg	40mg
Oxicodona	12						10mg		20mg		
Metadona	48-72h					5mg		10mg			
Buprenorfina Transdérmica (equivalência aproximada)								5mcg	10-20 mcg	20-30 mcg	30-40 mcg

Fonte: Autoria própria, 2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

5.5 Quando devemos fazer a rotação dos opioides?

- Efeitos adversos limitantes relacionado à droga;
- Analgesia insuficiente por mecanismos de tolerância farmacológica;
- Ajuste de via de administração por inviabilidade da atual ou mudança de posologia que trazem mais benefícios aos pacientes.

No momento da rotação, considerar que as doses podem ser ajustadas para cima ou para baixo e a equipolência analgésica dos opioides deve ser observada na Tabela 1. No momento da rotação de morfina para outro opioide, se a dor estiver controlada, se faz a redução da dose equianalgésica em 25-50%. Em caso de dor não controlada podemos aumentar a dose em até 50%.

Tabela 5: Principais efeitos secundários dos opioides

Efeito	Definição	Conduta
Sedação	Presente no início da terapia opioide ou no aumento da dose, estando relacionada com seu efeito anticolinérgico.	Reduzir ou trocar o opioide ou associar adjuvantes para aumentar a analgesia e diminuir a quantidade de opioide
Constipação	Frequência elevada. Único efeito que não desenvolve tolerância farmacológica.	Prescrever laxantes irritativos de horário (bisacodil, picossulfato ou senna). Orientar ingesta hídrica e alimentos laxativos.
Náusea e vômitos	Ocasionado por diminuição do peristaltismo e diminuição do tempo de esvaziamento gástrico. Controle após 3 a 7 dias.	Prescrever antieméticos: *haloperidol, metoclopramida (age no peristaltismo), ondansetrona (atuam na área de zona de gatilho)
Prurido	Consequência da administração pela via espinal.	Administrar Antihistaminico ou rodiziar antiémetico
Retenção urinária	Frequente na administração pela via espinal (subaracnóidea).	Passagem de SVD ou rodiziar opióide

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Efeitos Cardiovasculares	*__MORFINA__: vasodilatação e hipotensão (liberação de histamina) *__METADONA:__ prolongamento do intervalo QT e aparecimento de “torsades de pointes” no ECG.	No caso da **metadona**, diminuir a dose, aumentar o intervalo entre as doses e monitorar ECG
Hiperalgesia	Aumento da resposta ao estímulo doloroso, apesar da medicação.	Trocar de opioide
Mioclonia	Indicativo de neurotoxicidade facilitada por quadro de desidratação.	*Hidratar *Reduzir a dose em 25-30% *Pensar em rotacionar

Fonte: Adaptado de Manual de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio Libanês, 2023.

5.6 Intoxicação por opioide

Quadros de intoxicação por opioide são raros entre os pacientes oncológicos em uma unidade de urgência pois eles possuem o principal antídoto, que é a presença da dor e toda carga de estímulo nocivo na gênese da dor do câncer. A intoxicação pode ocorrer quando a fase inicial de titulação da dose é negligenciada e a administração de uma dose alta inicialmente pode levar a quadro de intoxicação. Os sinais mais comuns de intoxicação são: miose bilateral, sedação e depressão respiratória frequência dependente (FR < 10 ipm). Conduta recomendada até a reversão (FR >18 ipm).

- Não administrar a próxima dose de opioide;
- Reduzir a dose total diária em uso e considerar rever intervalos de administração;
- Instalar oxigenioterapia (cateter nasal, máscara facial);
- Manter as vias aéreas livres- posicionamento adequado e utilização de dispositivos supraglóticos (cânula de Guedel, máscara laríngea) se necessário;
- Otimizar hidratação EV;
- Reversão farmacológica. Necessidade de titular a dose de Naloxona para não induzir descompensações cardíacas, edema pulmonar entre outros;
- Iniciar com 0,04 mg, repetindo a cada 1 a 3 min, monitorando a FR e a pupila principalmente pois a melhora completa do nível de consciência pode demorar.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

5.7 Medidas não farmacológicas

O manejo da dor deve ir além do uso exclusivo de fármacos, incorporando estratégias não farmacológicas que contribuam para a promoção do conforto, da autonomia e da qualidade de vida dos pacientes. Essas medidas são reconhecidas e recomendadas por instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED).

As **medidas não farmacológicas** têm se mostrado eficazes na redução da dor aguda e crônica, elas proporcionam alívio sem os efeitos adversos associados aos medicamentos, fortalecem o vínculo terapêutico e favorecem uma abordagem humanizada, respeitando a singularidade de cada paciente.

As medidas não farmacológicas devem ser integradas de forma personalizada ao plano de cuidado, considerando o tipo e intensidade da dor, as preferências do paciente, o contexto clínico e os recursos disponíveis. A capacitação da equipe multiprofissional é fundamental para a adequada indicação e aplicação dessas intervenções, que devem ser embasadas em evidências científicas e alinhadas aos princípios do cuidado humanizado, seguro e centrado na pessoa.

5.8 Técnicas térmicas (calor e frio)

Compressas quentes (entre 40 a 45 °C, por até 30 minutos, 3 a 4 vezes ao dia) são indicadas em casos de dor articular, espasmos musculares e processos inflamatórios superficiais, promovendo vasodilatação, alívio da rigidez e relaxamento muscular.

Compressas frias (cerca de 15 °C, aplicadas por até 15 minutos, 3 a 4 vezes ao dia) são úteis no manejo de entorses, contusões e dores musculoesqueléticas agudas, por reduzirem o edema, a inflamação e a condução nervosa da dor.

5.9 Intervenções cognitivas e psicocorporais

Exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento: ajudam na autorregulação emocional e na modulação da dor, além de reduzirem a ansiedade.

Musicoterapia, meditação e mindfulness: atuam sobre o componente afetivo da dor, favorecendo a serenidade e a percepção de controle da situação dolorosa.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A música pode promover o conforto e favorecer o autocuidado. Ela não substitui o tratamento farmacológico, mas atua como recurso complementar auxiliando na medida em que reduz sentimentos de desalento e desesperança; desloca o foco da percepção da doença e da dor; favorece a imaginação, a reflexão e a introspecção, que podem induzir a emoções e estados de ânimos positivos; permite sensação de relaxamento e quebra o ciclo dor-ansiedade-tensão. Ela pode ser introduzida na urgência através de fones de ouvido.

Visualização positiva e estímulos afetivos: como a revisão de álbuns de fotos, a presença de familiares e visitas de líderes espirituais podem ressignificar a dor e fortalecer o bem-estar emocional.

5.10 Aspectos psicológicos

O sofrimento psíquico associado à dor total pode gerar prejuízos na expressão de demandas e na qualidade do diálogo entre as partes envolvidas, comprometendo a construção de estratégias efetivas de cuidados e de adaptação de demandas. Neste processo, cabe ao psicólogo auxiliar o paciente e familiares na construção de um diálogo ativo e assertivo com a equipe garantindo seu protagonismo durante o tratamento.

Nos momentos de fim de vida ou de impossibilidade do paciente, a psicologia também auxiliará a família, que deverá assumir esse lugar e garantir o cuidado nos aspectos emocionais, espirituais e sociais que extrapolam as competências da equipe de saúde. É importante nesse momento proporcionar o resgate de pendências, incentivar que as diretivas antecipadas anteriormente definidas sejam respeitadas.

Visualização positiva e estímulos afetivos: como a revisão de álbuns de fotos, a presença de familiares e visitas de líderes espirituais podem ressignificar a dor e fortalecer o bem-estar emocional.

6. RESPONSABILIDADES

No protocolo de dor oncológica, cada profissional da equipe de saúde desempenha um papel fundamental para garantir o controle adequado dos sintomas e a promoção do conforto do paciente.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- **Médico assistencial:** Responsável por realizar uma avaliação contínua e detalhada da dor, identificando suas causas e gravidade, e elaborando um plano de tratamento individualizado que integre intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Além disso, implementa estratégias eficazes para o controle da dor e de outros sintomas comuns, como náuseas, vômitos, dispneia, fadiga e questões psicossociais e espirituais. Mantém uma comunicação clara e empática com o paciente e sua família, coordenando os cuidados de forma integrada com os demais membros da equipe.

- **Enfermeiro:** Responsável pelo monitoramento constante dos sintomas, avaliando a resposta às intervenções e ajustando o plano de cuidados conforme necessário. Deve avaliar a dor considerando-a como o quinto sinal vital, realizar o registro adequado dessa avaliação, administrar os medicamentos com segurança e implementar medidas que promovam conforto e qualidade de vida. Também orienta o paciente e seus familiares sobre o manejo dos sintomas, o uso correto dos medicamentos e práticas de autocuidado, além de manter registros precisos e comunicação efetiva com a equipe multiprofissional.

- **Técnico de Enfermagem:** Responsável pelo monitoramento e registro dos sinais vitais, pela administração correta dos medicamentos conforme prescrição, e pela assistência direta ao paciente nas atividades de higiene, alimentação e mobilização. Também aplica medidas simples de alívio da dor, como mudanças de posição e cuidados com a pele, colabora com a documentação das intervenções realizadas e orienta o paciente e a família quanto aos cuidados básicos e ao uso dos medicamentos.

- **Farmacêutico:** Atua na avaliação e no gerenciamento da dor por meio da indicação e ajuste de terapias farmacológicas, colaborando também no manejo de sintomas como náuseas, fadiga e constipação. Trabalha em conjunto com a equipe para otimizar o tratamento medicamentoso, assegurando a eficácia e segurança das prescrições. Além disso, fornece orientações detalhadas ao paciente e seus cuidadores sobre o uso adequado dos medicamentos, incluindo doses, horários, forma de administração, interações e efeitos adversos,

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

e contribui para a educação permanente da equipe sobre boas práticas em cuidados paliativos.

- **Psicólogo:** Contribui com a avaliação e manejo do sofrimento emocional relacionado à dor, oferecendo suporte psicológico ao paciente e seus familiares. Atua na identificação de fatores psíquicos que podem intensificar a percepção da dor e desenvolve estratégias de enfrentamento que promovem o bem-estar mental, a adaptação à condição clínica e a melhoria da qualidade de vida.

7. INDICADORES

- Taxa de pacientes com dor oncológica controlada (dor <4) após tratamento.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

8. REFERÊNCIAS

Amy S. Kelley, M.D., M.S.H.S., and R. Sean Morrison, M.D. **Palliative Care for the Seriously Ill**. *N Engl J Med* 2015; 373:747-755.

Baron, R; Blinder, A; Wasner, G. **Neuropathic Pain: diagnosis, pathophysiological mechanisms, and treatment. Lancer Neurology**. 2010:9:807-819.

BASTOS, D. F. et al. **Dor**. *Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar*, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 85-96, 2007.

Cardoso MGM, Melo IT V. **Cuidados Paliativos em Dor**. In: Posso IP; Grossman E; Fonseca PRB; Perissinoti DMN; Oliveira Jr JO; Souza JB; Serrano SC, Vall J. *Tratado de Dor. Atheneu.* 2017. p. 121–32.

Cardoso MGM. **Estratégias no Manejo da Dor Total**. In: Dor e Cuidados Paliativos. Matos, SLL; Azevedo, MP; Cardoso, MGM; Nunes, RR. *Sociedade Brasileira de Anestesiologia*. 2018. p. 173–182.

Carvalho RT, Souza MR, Franck EM. **Manual da Residência em Cuidados Paliativos**. *Manole*, 1a edição, 2017.

.

DanieL Vardeh, Richard J Mannion, AND Clifford J Woolf Tow**ards a mechanism-based approach to pain diagnosis**. *J Pain*.2016; September ; 17(9 Suppl): T50–T69.

Evenepoel, Margaux et al. "**Pain Prevalence During Cancer Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis**." *Journal of pain and symptom managementvol*. 63,3 (2022): e317-e335.

George N, Phillips E, Zaurova M, et al. Palliative Care Screening and Assessment in the Emergency Department: A Systematic Review. *J Pain Symptom Manage*, 2016; 51:108.

KUREBAYASHI, L. F. S.; FREITAS, G. F.; OGUISSO, T**. Enfermidades tratadas e tratáveis pela acupuntura segundo percepção de enfermeiras**. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 930-936, 2009.

Manual da ANCP- *Academia Nacional de Cuidados Paliativos*, 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Diretrizes sobre o manejo da dor crônica em crianças**. Genebra: *OMS*, 2020.

Quill TE**. Perspectives on care at the close of life. Initiating end-of-life discussions with seriously ill patients: addressing the "elephant in the room".** *JAMA* 2000; 284:2502.

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA DOR (SBED). **Diretrizes para avaliação e manejo da dor crônica no Brasil**. São Paulo: *SBED*, 2021.

Swarm RA, Abernethy AP, Anghelescu DL, et al. Adult cancer pain. J Natl Compr Canc Netw 2013; 11:992.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

T Reed, R.D; Jensen, T.S; Campbell, J.N. et al., **Neuropathic Pain: redefinition and a grading system for clinical and research purpose**. *Neurology* 2008: 70:1630-1635.

Teixeira. M.J; **Fisiopatologia da Dor**. In: Posso IP; Grossman E; Fonseca PRB; Perissinoti DMN; Oliveira Jr JO; Souza JB; Serrano SC, Vall J. *Tratado de Dor Atheneu*. 1:155-198, 2017.

Twycross R. **Introducing Palliative Care**. *4°Ed Radcliff Med Press*, p 4-8, 2003.

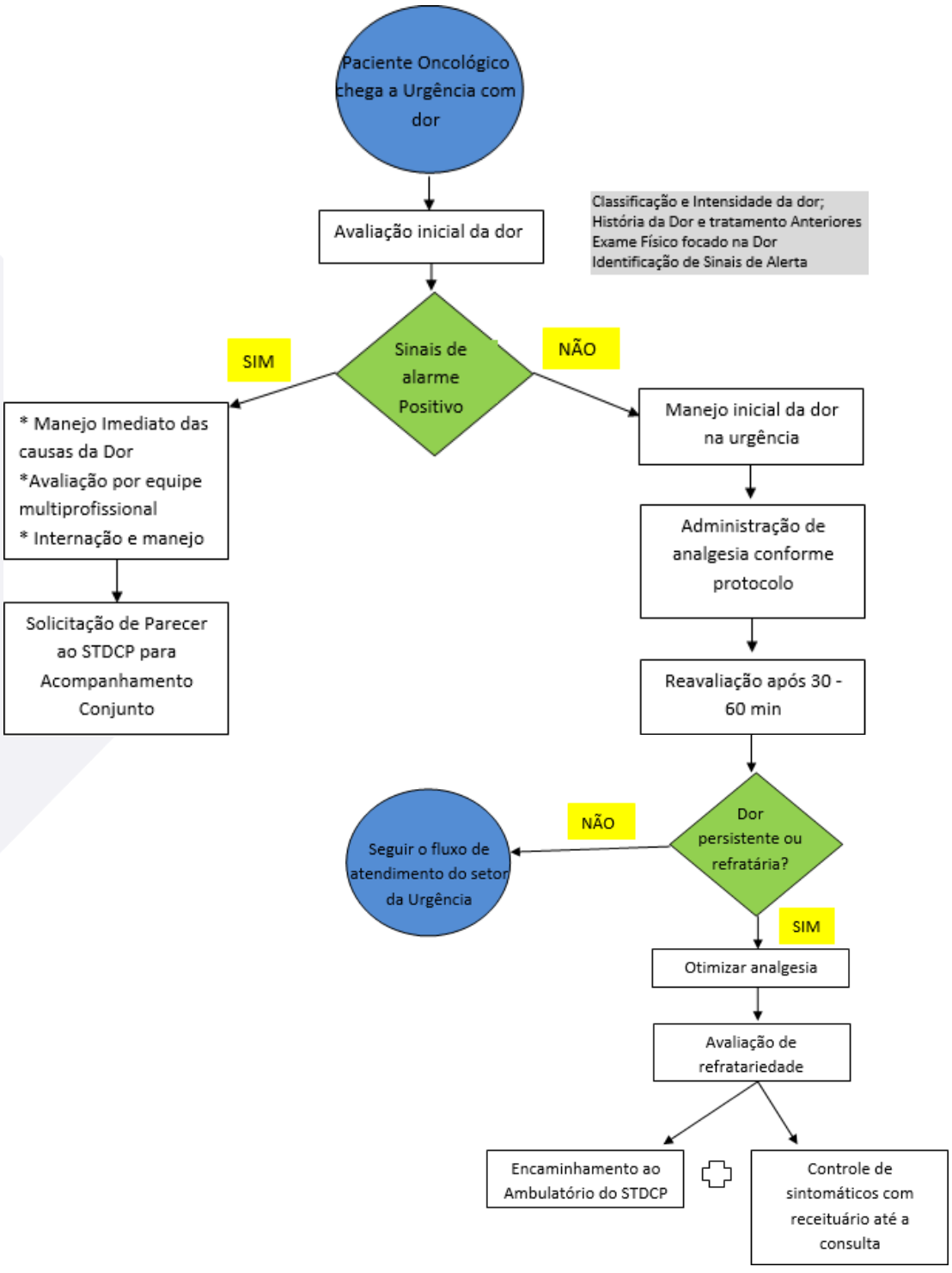
Wiermann EG et al. **Consenso Brasileiro sobre Manejo da Dor relacionada ao Câncer**. *Revista Brasileira de Oncologia Clínica*. 2014;10(38) 132-143.

Wolfe F et all. F**ibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological studies: a modification of the ACR Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia**. *J Rheumatol*.2011; 38:1113–1122.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

9. ANEXOS

Anexo I – Fluxograma de avalição da dor



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Anexo II – Ferramenta de risco de opioide

Esta ferramenta deve ser aplicada aos pacientes em uma consulta inicial, antes do início da terapia com opioides para controle da dor. Uma pontuação de 3 ou menos indica baixo risco de abuso futuro de opioides, uma pontuação de 4 a 7 indica risco moderado de abuso de opioides e uma pontuação de 8 ou mais indica alto risco de abuso de opioides.

Marque o que se aplica	Feminino	Masculino
Histórico familiar de abuso de substâncias		
Álcool	1	3
Drogas Ilegais	2	3
Drogas regulamentadas	4	4
História pessoal de abuso de substâncias		
Álcool	3	3
Drogas Ilegais	4	4
Drogas regulamentadas	5	5
Idade entre 16 e 45 anos	1	1
História de abuso sexual na pré-adolescência	3	0
Doenças psicológicas		
Transtorno de Deficit de Atenção e hiperatividade (TDAH), Transtorno Desafiante Opositor (TOD) e esquizofrenia	2	2
Depressão	1	1
Score Total		

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Anexo III – Ficha de qualidade de indicador

INDICADOR	
TÍTULO	Taxa de pacientes com dor oncológica controlada (dor<4) após tratamento
Descrição	Refere-se à porcentagem de pacientes em observação no serviço de urgência que após serem medicados, tiveram sua dor de intensidade alta e moderada, reduzida para pelo menos dor <4.
Propósito do indicador	Avaliar a eficácia do tratamento em reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida dos paciente oncologicos, e a satisfação com o tratamento ofertado.
Interpretação	Mede a proporção de pacientes que tiveram sua dor controlada após serem submetidos ao tratamento de dor padronizado pelo protocolo institucional
Usos	Gestão e avaliação da assistência para dor
Métodos de cálculo	**Fórmula:** N° de pacientes com dor<4 após tratamento **Numerador:** Número de pacientes com dor oncológica <4 após tratamento.**Denominador:** Total de pacientes com dor oncológica em observação na urgência x 100
Tipo de indicador	Taxa
Unidades de medida	Porcentagem (%)
Frequência de mensuração	Apuração e compilação mensal
Área de referência	Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas
Período de tempo de referência	2025
Nível de desagregação	Pacientes adultos com doenças oncológicas atendidos numa unidade pública
Fontes do dados	Prontuários físico e no sistema SALUX
Polaridade	Quanto MAIOR, melhor
Limitações	O alto volume de pacientes atendidos na urgência e a grande rotatividade de médicos plantonistas podem dificultar o seguimento do protocolo.
Instituição responsável	FCECON – Gerência do STDCP e Gerência da Urgencia

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Notas Técnicas	Se houver indisponibilidade de dados, e/ou registros inadequados e/ou tratamento inadequado da dor, o indicador pode ser afetado, comprometendo a avaliação da prática assistencial.

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	05/12/2025	Elaboração do Protocolo

Elaboração: • Mirlane Guimarães de Melo Cardoso – Gerente do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos	**Data:** 05/12/2025 Documento assinado digitalmente gov.br MIRLANE GUIMARAES DE MELO CARDOSO Data: 17/12/2025 18:01:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
• Maressa Gasparoto Lenglube Lisboa – Enfermeira Assistencial do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos	Documento assinado digitalmente gov.br MARESSA GASPAROTO LENGLUBE LISBOA Data: 17/12/2025 19:37:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação: Gerson Antônio dos Santos Mourão – Diretor Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215 Assinado de forma digital por GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215

Assinado digitalmente por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA em 18/12/2025 às 11:02:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/C9E5.D5DF.855C.F4CD/283CA266
Código verificador: **C9E5.D5DF.855C.F4CD** CRC: **283CA266**